.*.**

C*

专家共识

GS/CACM ****—202*

急性细菌性结膜炎中医病证诊断与疗效评价专家共识

The expert consensus on diagnosis and therapeutic effect evaluation of diseases and syndromes in traditional Chinese medicine of acute bacterial conjunctivitis

（完成时间：20**年*月）

20**-**-**发布　　20**-**-**实施

中华中医药学会发布

中华中医药学会专家共识公示稿

目 次

前言……I
引言……II
1 范围……1
2 规范性引用文件……1
3 术语和定义……1
4 诊断……1
4.1 西医疾病诊断……1
4.2 证候分类及诊断……2
5 疗效评价……2
5.1 中医证候疗效评价指标……2
5.2 疾病疗效评价……6
5.3 疗效评价时间……6
6 急性细菌性结膜炎中医病证结合防治的基本原则……6
附录 A （资料性）现有急性细菌性结膜炎中医诊断相关标准……8
参考文献 ……9

中华中医药学会
专家共识公示稿

前　言

本文件参照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国中医科学院西苑医院提出。

本文件由中华中医药学会归口。

本文件起草单位：中国中医科学院眼科医院、中国中医科学院西苑医院、成都中医药大学附属医院、北京同仁医院、辽宁中医药大学附属医院、中国中医科学院广安门医院、北京中医药大学第三附属医院、北京世纪坛医院、山东中医药大学附属眼科医院、广东省中医院、北京中医药大学东方医院、长春中医药大学附属医院、黑龙江中医药大学附属医院、北京医院、四川省人民医院、四川大学华西医院、贵州中医药大学附属医院、安康市中医医院、苏州市中医医院。

本文件主要起草人：接传红、高蕊、郑燕林、接英、左韬

本文件其他起草人：吴烈、陶永健、王志强、徐冰、解孝锋、庞龙、周剑、周婉瑜、夏清艳、褚利群、姚靖、喻晓兵、邱波、吴峥峥、陆方、钟捷、毕宏生、王方、沈兰珂、王建新、赵飞燕、孙明月、代欣玥、张国瑗、钱真真、王桂杰

中华中医药学会
专家共识公示稿

引　言

急性细菌性结膜炎为细菌感染引起的眼科急症，以单眼或双眼异物感、畏光、结膜充血、分泌物增多为主要特征。临床上本病病情较重，发展较快，最常用的方法为中西医结合治疗。西医治疗多以抗生素滴眼液为主，但仍难以达到满意疗效。

中医学将急性细菌性结膜炎称为“天行赤眼”，临床上常用中药内服或中药滴眼液等疏风清热、表里双解疗法为主，具有较好的疗效。但目前尚缺乏急性细菌性结膜炎相关中医临床诊断与疗效评价规范，影响了中医药在防治急性细菌性结膜炎改善红肿热痛等优势发挥。此外，对于中药新药研发来说，既往的证候类型已不能满足新药研发的需求。因此，目前缺乏的急性细菌性结膜炎相关中医临床诊断与疗效评价规范，影响了中医药在防治急性细菌性结膜炎中的应用以及新的中药制剂研发。

为进一步规范中医药在急性细菌性结膜炎防治过程中的中医诊疗行为与疗效评价并且满足治疗急性细菌性结膜炎的中药新药研发的需求，起草组在广泛检索文献基础上，组织国内相关领域中、西医临床专家及方法学专家，根据专家共识制定流程及中华中医药学会团体标准管理办法等相关要求，研制《急性细菌性结膜炎中医病证诊断与疗效评价专家共识》。

本文件的内容涉及急性细菌性结膜炎的中医疾病诊断标准、证候诊断标准和原则，以及疗效评价方法，对于指导中医药防治急性细菌性结膜炎的临床实践和科学研究的开展、提高急性细菌性结膜炎的整体防治水平具有重要意义。

中华中医药学会
专家共识公示稿

急性细菌性结膜炎中医病证诊断与疗效评价专家共识

1 范围

本文件给出了急性细菌性结膜炎的中医疾病诊断标准、证候诊断标准、疗效评价指标和评价方法。

本文件适用于急性细菌性结膜炎的中医病证诊断和临床疗效评价。

本文件适合中医师、中西医结合医师、临床研究人员及药企使用。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ZYYXH/T288-2012 中医眼科常见病诊疗指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1风热赤眼 wind heat and red eye

风热未眼是指外感风热，引动内火，风火相煽，循经上犯于目，而猝然发病，以白睛红赤、眵多黏稠、痒痛交作为主要特征的眼病。

[来源：《中医眼科学》(全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材)]

3.2 急性细菌性结膜炎 acute bacterial conjunctivitis

ICD-11编码：H10.901，是以显著的结膜充血、脓性或黏液脓性分泌物为特征的疾病。是由细菌感染引起的一种急性流行性眼病，又称急性卡他性结膜炎(acute catarhal conjunctivitis)。本病多发于盛夏或春秋之季，传染性强，可散发感染，也可流行于学校、幼儿园等集体场所。潜伏期短（1～3天），发病急，双眼同时或相隔1～2天发病，一般在发病3～4天炎症最重，后逐渐减轻，病情一般不超过3周。最常见的致病菌是肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌和流感嗜血杆菌。

[来源：ZYYXH/T288-2012 《中医眼科常见病诊疗指南》]

4 诊断

4.1 西医疾病诊断

a）病史：单眼患病，或双眼同时/先后患病，发病急，多有传染源接触史。

b）症状：初起眼部有沙涩、异物感。继而自觉流泪、畏光灼热、刺痛、异物感加重，分泌物多，视力一般不受影响。分泌物过多时，可有暂时性视物模糊。

中华中医药学会 专家共识公示稿

c）体征：眼睑肿胀，结膜充血，伴有分泌物，分泌物起初为较稀的浆液性，后随病程发展变为黏液性及脓性。严重时可有假膜形成。

d）检查：分泌物涂片或结膜刮片检查见嗜中性粒细胞和细菌菌体。

根据病史、症状及局部检查所见，即可诊断。

4.2 中医证候分类及诊断

4.2.1 风热表证

主症：异物感或烧灼感，结膜充血，分泌物增多。

次症：眼痒，眼睑红肿，畏光，流泪，发热，恶风，头痛。

舌象脉象：舌红，苔薄黄，脉浮数。

符合疾病诊断标准，同时符合上述证候诊断标准中全部主症，加次症眼部症状至少两项和其他症状至少两项，参考舌脉，即可诊断。

4.2.2 肺经风热证

主症：异物感或烧灼感，结膜充血，分泌物增多。

次症：眼睑红肿，畏光，流泪，发热，咳嗽，痰黄，口渴，便秘。

舌象脉象：舌红，苔薄黄，脉数。

符合疾病诊断标准，同时符合上述证候诊断标准中全部主症，加次症眼部症状至少两项和其他症状至少两项，参考舌脉，即可诊断。

4.2.3 肝经火旺证

主症：异物感或烧灼感，结膜充血，分泌物多而黏稠。

次症：眼睑红肿，烦躁易怒，胁胀或胁痛，畏光，口干或口苦，眩晕，面红耳赤，头胀痛，耳鸣。

舌象脉象：舌红，苔黄，脉弦或弦数。

符合疾病诊断标准，同时符合上述证候诊断标准中全部主症，加次症三项，参考舌脉，即可诊断。

5 疗效评价

5.1 中医证候疗效评价指标

采用中医证候积分量表进行评价，各证候的量表条目及评分标准为：

a）风热表证分级量化标准见表1。

表1：风热表证分级量化标准

主症		评分
异物感或烧灼感	□无异物感或烧灼感	0 分
	□沙粒样感或烧灼感较轻	2 分

中华中医药学会 专家共识公示稿

	□沙粒样感或烧灼感较重，尚可忍受 □沙粒样感或烧灼感较重，难以忍受	4 分 6分
结膜充血	□无充血 □充血局限在穹窿部，血管呈鲜红色 □充血明显达睑裂部，血管呈深红色，模糊不清 □整个结膜弥漫充血，血管呈紫红色，看不清正常睑板纹理	0分 2分 4分 6分
分泌物	□无分泌物或少量清亮、透明的液体分泌物 □少量分泌物，稀而混浊 □较多分泌物，黏液脓性，伴碎屑 □黏液脓性分泌物如牙膏，糊住眼睛而睁眼困难	0分 2分 4分 6分
次症		评分
眼痒	□无眼痒 □眼痒明显，伴有轻微热感 □轻微眼痒，眼部皮温升高 □极痒难忍，眼部灼热	0分 1分 2分 3分
眼睑红肿	□无红肿 □微微红肿 □红肿明显 □眼睑红肿如桃	0分 1分 2分 3 分
畏光	□无畏光 □轻度畏光，不需要佩戴太阳镜 □中度畏光，需要佩戴太阳镜 □重度畏光，佩戴太阳镜无效	0分 1分 2分 3分
流泪	□无流泪 □偶发轻微流泪，无需擦拭，不影响日常生活 □间断性流泪，需偶尔擦拭，轻度影响工作或社交 □持续性流泪，需反复擦拭，明显干扰日常生活或视觉清晰度	0分 1分 2分 3分
发热	□无 □有	0分 1分
恶风	□无 □有	0分 1分
头痛	□无 □有	0分 1分
舌脉象不计分		
舌象	舌红，苔薄黄。	
脉象	脉浮数	

b）肺经风热证分级量化标准见表2。

表2：肺经风热证分级量化标准

主症		评分
异物感或烧灼感	□无异物感或烧灼感 □轻度沙粒样感或烧灼感 □中度沙粒样感或烧灼感 □沙粒样感或烧灼感难以忍受	0 分 2 分 4 分 6分
结膜充血	□无充血 □充血局限在穹窿部，血管呈鲜红色	0分 2分

	□充血明显达睑裂部，血管呈深红色，模糊不清 □整个结膜弥漫充血，血管呈紫红色，看不清正常睑板纹理	4分 6分
分泌物	□无分泌物或少量清亮、透明的液体分泌物 □少量分泌物，稀而混浊 □较多分泌物，黏液脓性，伴碎屑 □黏液脓性分泌物如牙膏，糊住眼睛而睁眼困难	0分 2分 4分 6分
次症		评分
眼睑红肿	□无红肿 □微微红肿 □红肿明显 □眼睑红肿如桃	0分 1分 2分 3分
畏光	□无畏光 □轻度畏光，不需要佩戴太阳镜 □中度畏光，需要佩戴太阳镜 □重度畏光，佩戴太阳镜无效	0分 1分 2分 3分
流泪	□无流泪 □偶发轻微流泪，无需擦拭，不影响日常生活 □间断性流泪，需偶尔擦拭，轻度影响工作或社交 □持续性流泪，需反复擦拭，明显干扰日常生活或视觉清晰度	0分 1分 2分 3分
发热	□无 □有	0分 1分
咳嗽	□无 □有	0分 1分
痰黄	□无 □有	0分 1分
口渴	□无 □有	0分 1分
便秘	□无 □有	0分 1分
舌脉象不计分		
舌象	舌红，苔薄黄，脉数。	
脉象	脉数	

c）肝经火旺证分级量化标准见表3。

表3：肝经火证分级量化标准

主症		评分
异物感或烧灼感	□无异物感或烧灼感 □轻度沙粒样感或烧灼感 □中度沙粒样感或烧灼感 □沙粒样感或烧灼感难以忍受	0 分 2 分 4 分 6分
结膜充血	□无充血 □充血局限在穹窿部，血管呈鲜红色 □充血明显达睑裂部，血管呈深红色，模糊不清 □整个结膜弥漫充血，血管呈紫红色，看不清正常睑板纹理	0分 2分 4分 6分
分泌物	□无分泌物或少量清亮、透明的液体分泌物 □少量分泌物，稀而混浊	0 分 2 分

	□较多分泌物，黏液脓性，伴碎屑 □黏液脓性分泌物如牙膏，糊住眼睛而睁眼困难	4 分 6 分
次症		评分
眼睑红肿	□无红肿 □微微红肿 □红肿明显 □眼睑红肿如桃	0分 1分 2分 3分
烦躁易怒	□无烦躁易怒； □偶轻微烦躁，稍作心理平息即可恢复，可伴有注意力分散； □心烦急躁，遇事易怒，需做深呼吸或放松活动方可控制，可伴有提高音量、心跳加速、出汗、焦虑、抑郁或自责情绪，工作效率下降； □心烦不安，勃然大怒，无法自控，可伴有讽刺或辱骂他人、摔打物品、肌肉紧绷、家庭冲突、朋友疏远或职场矛盾、学业或工作困难	0分 1分 2分 3分
胁胀或胁痛	请患者勾选 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 □0 无胀满疼痛感； □1-3 轻微胀满，叹气时有所缓解，疼痛轻微，偶尔发生； □4-7 胀满不适，尚可忍受，疼痛明显，时作时止； □8-10胀满明显，影响工作和生活，持续性疼痛	0分 1分 2分 3分
畏光	□无畏光 □轻度畏光，不需要佩戴太阳镜 □中度畏光，需要佩戴太阳镜 □重度畏光，佩戴太阳镜无效	0分 1分 2分 3分
口干或口苦	□无 □有	0分 1分
眩晕	□无 □有	0分 1分
面红耳赤	□无 □有	0分 1分
头胀痛	□无 □有	0分 1分
耳鸣	□无 □有	0分 1分
舌脉象不计分		
舌象	舌红，苔黄	
脉象	脉弦或弦数	

5.1.2 中医证候疗效评价依据

采用治疗前、后量表总积分减分值进行证候疗效评价。

5.2 疾病疗效评价依据

中华中医药学会公示稿

采用临床症状或体征消失率、消失时间评价疾病疗效。临床症状或体征包括眼痛（异物感或烧灼感）、眼分泌物、球睑结膜充血三项。

眼痛（异物感、烧灼感等）消失的定义：以眼痛 VAS 评分来评价眼痛症状，眼痛 VAS 评分≤1 分定义为眼痛消失。

眼分泌物消失的定义：以《中国睑板腺功能障碍专家共识:诊断和治疗(2023 年)》评分来评价眼分泌物症状，眼分泌物=0 分的时间定义为眼分泌物消失。

球睑结膜充血消失的定义：以 IER 分级量表来评价结膜充血，IER 分级=0 级/1 级的时间定义为球睑结膜充血消失。

眼痛（异物感、烧灼感等）消失率：眼痛（异物感、烧灼感等）消失人数的占比。

眼痛（异物感、烧灼感等）消失时间：从服药开始到眼痛（异物感、烧灼感等）消失的时间。

眼分泌物消失率：眼分泌物消失人数的占比。

眼分泌物消失时间：眼分泌物消失的时间。

球睑结膜充血消失率：球睑结膜充血消失人数的占比。

球睑结膜充血消失时间：从服药开始到球睑结膜充血消失的时间。

5.3 疗效评价时间

治疗5天后进行疗效评价。

6 急性细菌性结膜炎中医病证结合防治的基本原则

6.1 内治法

6.1.1 疏风清热法

以辛凉解表为主，用疏风散热、解除风邪的方法，适用于轻度急性细菌性结膜炎，如银翘散等。

6.1.2 泻火解毒法

用寒性药物，通过清热泻火解毒来消除火热邪毒，适用于中-重度急性细菌性结膜炎，如泻肺饮等。

6.1.3 清肝明目法

清肝明目法是用清肝明目药物为主配伍而成，以清除肝经火热、达到明目作用的方法，可贯穿于急性细菌性结膜炎治疗全过程，如熊胆等。

6.2 外治法

6.2.1 滴眼法

最常用的治疗方法，如清热解毒、清肝明目类中药滴眼液。

中华中医药学会专家共识公示稿

6.2.2 超声雾化法

在继承中医熏洗法的基础上，结合超声雾化工作原理，采用冷雾化法，通过超声波的作用使药物雾化、形成微小的雾粒，使眼的结膜直接接触眼部，从而达到治疗眼病的目的，如白芷、防风、菊花、黄连等药煎汤置超声雾化器中喷雾患眼。

6.2.3 耳尖放血

耳尖属经外奇穴，为治疗眼疾的要穴，通过刺激耳部特定穴位（耳尖）放血，可达到疏风清热、泻火解毒、清肝明目的作用。

中华中医药学会专家共识公示稿

附 录 A

（资料性）

现有急性细菌性结膜炎中医诊断相关标准

目前国内急性细菌性结膜炎中医诊断相关内容描述见表A.1。

表 A.1 目前国内急性细菌性结膜炎中医诊断相关内容

时间	标准来源	发布机构	相关内容
	中医眼科常见病诊疗指南	中华中医药学会	中医诊断要点 1.风重于热证 患眼痒涩交作，灼热感、畏光、结膜充血、黏液或水样分泌物，眼睑微肿等，可伴有恶风发热头痛鼻塞,舌质红,苔薄白或微黄,脉浮数。 2.热重于风证 患眼灼热疼痛较重，怕热畏光，分泌物多而黏稠，流泪，眼睑红肿，结膜充血，可兼有口渴，便秘溲赤，苔黄，脉数。 3.风热并重证 患眼灼热疼痛，刺痒较重，怕热畏光，球结膜红赤甚至水肿，兼见恶风发热，头痛鼻塞，口渴便秘，溲赤，苔黄，脉数。

中华中医药学会
专家共识公示稿

参 考 文 献

[1]上海市突发急性眼部疾病公共卫生应急防控和管理专家组,林森林.感染性结膜炎临床眼科防控专家共识[J].上海医药,2021,42(02):3-8.

[2]张湘悦.中医药治疗急性结膜炎研究进展[J].中国医药导刊,2024,26(09):892-895.

[3]金明.现代中医眼科学［M］.第1版.北京:中国医药科技出版社,2020.

[4]彭清华,龙达.中西医结合眼表疾病学［M］.第1版.湖南:湖南科学技术出版社,2021.

[5]张湘悦.中医药治疗急性结膜炎研究进展[J].中国医药导刊,2024,26(09):892-895.

[6]罗江,杨艺萌,肖媛媛,等.针灸治疗细菌性结膜炎的研究进展[J].新疆中医药,2023,41(06):140-142.

[7]姜洋,李莹,龙琴,等.急性细菌性结膜炎最新病原学分析[J].眼科新进展,2016,36(03):281-282+287.

中华中医药学会
专家共识公示稿